

보건복지부 고시 제2026-159호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2026-133호(2026. 6. 24.)을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 7월 29일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 “[219] Tenecteplase 주사제(품명: 메탈라제주 25밀리그램), [421] Obinutuzumab 주사제(품명: 가짜이바주)”를 별지 1과 같이 신설하고, “[142] Dupilumab 주사제(품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램 등), [142] Pegcetacoplan 주사제(품명: 엠파벨리주), [339] Emicizumab 주사제(품명: 험리 브라피하주사30mg 등), [339] Romiplostim 주사제(품명: 로미플레이트주250마이크로그램), [396] Empagliflozin 경구제(품명: 자디앙정 10밀리그램 등)”의 세부 인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 8월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[219] 기타의 순환계용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[219] Tenecteplase 주사제 (품명: 메탈라제주 25밀리그램)	<신 설>	허가사항 범위(성인의 급성 허혈성 뇌졸중에 증상 발현 후 4.5시간 이내에 투여한 경우) 내에 투여 시 요양급여를 인정함.	○ Tenecteplase 주사제 (품명: 메탈라제주 25mg)가 신규 등재 예정임에 따라 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 및 전문가의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함
※ 관련근거			
1) FDA (2025.2.)			
2) EMA (2023.12.)			
3) Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9e			
4) Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21st, 22nd Edition			
5) Dipro’s Pharmacotherapy: A pathophysiologic Approach, 13th Edition			
6) 한국뇌졸중학회 Tenecteplase in Acute Ischemic Stroke (2025)			
7) European Stroke Organisation (ESO) expedited recommendation on tenecteplase for acute ischaemic stroke (2023)			
8) Ischemic stroke Guidelines (2019)			

9) Key Changes to the 2022 Acute Stroke Management Canadian Stroke Best Practice Recommendations (2022)

10) Bijoy K Menon Intravenous tenecteplase compared with alteplase for acute ischemic stroke in Canada Lancet 2022;400:161-69

11) Yongjun Wang Tenecteplase versus alteplase in acute ischaemic cerebrovascular events (TRACE-2): a phase 3, multicentre, open-label, randomised controlled, non-inferiority trial Lancet 2023; 401: 645-54

12) Keith W Muir Tenecteplase versus alteplase for acute stroke within 4·5h of onset (ATTEST-2): a randomised, parallel group, open-label trial Lancet Neurol 2024; 23: 1087-96

13) Xia Meng Tenecteplase vs Alteplase for Patients With Acute Ischemic Stroke The ORIGINAL Randomized Clinical Trial JAMA. 2024;332(17):1437-1445

14) Mark W Parsons Tenecteplase versus alteplase for thrombolysis in patients selected by use of perfusion imaging within 4·5 h of onset of ischaemic stroke (TASTE): a multicentre, randomised, controlled, phase 3 non-inferiority trial Lancet Neurol 2024; 23: 775-86

15) B.C.V. Campbell Tenecteplase versus Alteplase before Thrombectomy for Ischemic Stroke N Engl J Med 2018;378:1573-82.

16) 한국뇌졸중학회 (대뇌학 제2025-110, 2025.12.11.)

17) 대한신경외과학회 (25-보험-251, 2025.12.17.)

18) NICE (2024.07.24.)

19) HAS (2024.12.03.)

[421] 항악성종양제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[421] Obinutuzumab	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	○ 오비누투zumab 주사제의 추가된 식약처 허가사항에 대해 전액 본인 부담으로 투여 가능

주사제 (품명: 가짜이바주)		- 아 래 - ○ 항암요법에 투여 시 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 범위 내에서 사용하는 경우	함을 명확히 함
※ 식약처 허가사항 변경(루푸스 신장염 적응증 추가, '26.6.11.)에 따른 급여기준 변경			

[별지 2]

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠트 프리필드주 300밀리그램 등)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. (생 략) 2. 중증 제2형 염증성 천식 가.~라. (생 략) <u><추 가></u>	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. (현행과 같음) 2. 중증 제2형 염증성 천식 가.~라. (현행과 같음) <u>마. 자가주사제인 점을 고려하여, 동 약제의 투</u> <u>여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’</u> <u>를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리</u> <u>하여야 함.</u> <u>바. 장기처방시 1회 처방 기간은 퇴원 및 외래의</u> <u>경우에는 최대 4주분까지로 함. 단, 최초 투</u> <u>약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도</u> <u>를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우에는</u> <u>최대 8~12주분까지 인정함.</u>	○ 장기 처방 시 발생할 수 있는 모니터링 공백 을 최소화하고, 타 생물 학적 제제와의 장기처 방 기준의 형평성(일관 성)을 위해 변경함

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Pegcetacoplan 주사제 (품명: 엠파벨리주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) 1) ~ 4) (생 략) 5) 투여 및 약제관리 가) 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이 상 성공적인 자가투여를 병원에서 확 인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 2주 분까지 요양급여를 인정함. (단, 최초 투약일로 부터 <u>3개월 이후</u> 에 질병상태 가 안정적이고 부작용이 없는 경우 최 대 4주분까지 인정함.) 나) (생 략) 6) (생 략) 2. (생 략)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) 1) ~ 4) (현행과 같음) 5) 투여 및 약제관리 가) 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이 상 성공적인 자가투여를 병원에서 확 인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 2주 분까지 요양급여를 인정함. (단, 최초 투약일로 부터 <u>1개월 이후</u> 에 질병상태 가 안정적이고 부작용이 없는 경우 최 대 4주분까지 인정함.) 나) (현행과 같음) 6) (현행과 같음) 2. (현행과 같음)	○ 교과서, 가이드라인, 임 상 연 구 문 헌 , 전문가 의견 등을 참조하여 장기처방 기준을 변경함.
※ 관련문헌 · Harrison’s Principles of Internal Medicine, 22e, 2025 > Chapter 105: Hemolytic Anemias			

- Williams Hematology, 10e, 2021 > Chapter 41: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
- Hematology; Basic Principles and Practice, 8e, 2022 > Chapter 32 PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA
- Onkopedia Guideline DGHO; German Society for Hematology and Medical Oncology, 2024.
- Peter Hillmen, et. al., Pegcetacoplan versus Eculizumab in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, N Engl J Med. 2021;384:1028-37.
- Régis Peffault de Latour, et. al., Pegcetacoplan versus eculizumab in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PEGASUS): 48-week follow-up of a randomised, open-label, phase 3, active-comparator, controlled trial, Lancet Haematol 2022;9: e648-59
- Raymond Siu Ming Wong, et. al., Pegcetacoplan controls hemolysis in complement inhibitor-naïve patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, Blood Ave 2023. 7(11):2468-2478.
- Carlos de Castro, et. al., Efficacy and Safety Maintained up to 3 Years in Adults with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Receiving Pegcetacoplan, Adv Ther.2025;42:4641-4658
- PBAC(2025)
- NICE(2022)
- CADTH(2023)
- SMC(2022)

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	

[339] Emicizumab 주사제 (품명: 헵리브라 피하주사 30mg 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. (생 략) 2. 만 1세 이상의 제8인자 항체를 보유하지 않은 중증(응고인자 활성도가 1% 미만) A형 혈우병 환자 가. (생 략) 나. (생 략) 다. 투여중지 기준 해당 약제 투여 이후 6개월마다 평가하여 ABR*(자발출혈 또는 일상생활 관련 출혈)이 5 이상일 경우 * ABR(Annualized bleed rate) = 출혈횟수/(치료일수/365.25) 라. 8인자제제와 동시 처방 ○ Emicizumab 유지요법 중인 환자에서 8인자제제의 처방은 출혈이 있어 내원 시 원내에서의 투여분과 외래에서의 20-25 IU/kg 2회분 처방에 한해 인정함. - 다만, 중등도(moderate) 이상 출혈의 경우 의사의 의학적 판단에 따라서 최대 30 IU/kg	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) 다. 투여중지 기준 해당 약제 투여 이후 6개월마다 평가하여 8인자제제로 치료를 요하는 자발출혈(Treated spontaneous ABR*)이 5 이상일 경우 * ABR(Annualized bleed rate) = 출혈횟수/(치료일수/365.25) 라. 8인자제제와 동시 처방 1) 입원환자(출혈이 있어 입원 또는 수술 및 시술 전 출혈예방 시)의 경우 각 8인자제제의 허가사항 범위 내에서 투여 시 인정함. 2) 외래환자의 경우 출혈이 있어 내원 시 원내에서의 투여분과 2회분 처방에 한해 인정하며, 1회 투여용량은 각 8인자제제의 1회 투여용량을 따름.	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 참조하여 비항체 환자의 투여중지 기준 및 8인자제제와 동시 처방 기준을 명확화하고 부하용량 원내투여 조건 기준을 변경함.
---	--	---	--

	3. 투여 방법 부하용량 투여 기간 동안 원내 투여를 원칙으로 하며, 해당기간 동안<삭제> 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이상 성공적인 자가투여를 병원에서 확인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 4주분까지 요양급여를 인정함. 이후 처방은 투약 등의 확인을 위한 일지를 환자 및 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리한 경우에 한함. 4. (생략)	3. 투여 방법 부하용량 첫 투여 1회는 원내 투여를 원칙으로 하며, 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이상 성공적인 자가투여를 병원에서 확인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 4주분까지 요양급여를 인정함. 이후 처방은 투약 등의 확인을 위한 일지를 환자 및 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리한 경우에 한함. 4. (현행과 같음)	
--	---	--	--

※ 관련근거

- Hematology: Basic Principles and Practice, 8e, 2022, Chapter 134. Hemophilia A and B
- Conn's Current Therapy 2025, Chapter Hemophilia and Related Conditions
- Current Medical Diagnosis & Treatment 2026, 16-08_ Congenital Disorders of Coagulation
- Williams Hematology, 10e, 2021_Chapter 122_ Hemophilia A and Hemophilia B
- WFH Guidelines for the Management of Hemophilia 3rd Edition, 2020
- MASAC Document #268 - RECOMMENDATION ON THE USE AND MANAGEMENT OF EMICIZUMAB-KXWH(HEMLIBRA®) FOR HEMOPHILIA A WITH AND WITHOUT INHIBITORS (2022)
- Specialist services for haemophilia and related bleeding disorders (adults and children), 2025
- DRAFT Recommendations for public comments: The annual bleeding rate (ABR) in hemophilia - Harmonizing definition, recording and reporting: Recommendations of ISTH - SSC FVIII / IX Sub-committee Working Group(2024)
- Rayment R, et al. Guidelines on the use of prophylactic factor replacement for children and adults with Haemophilia A and B. Br J Haematol. 2020 Sep;190(5):684-695.
- Holstein K, et al. Practical Guidance of the GTH Haemophilia Board on the Use of Emicizumab in Patients with Haemophilia A. Hämostaseologie 2020 Dec;40(5):561-571.

- Nordic Hemophilia Council Hemophilia Guidelines, 2025
- Coppola A, et al. Management of patients with severe haemophilia a without inhibitors on prophylaxis with emicizumab: AICE recommendations with focus on emergency in collaboration with SIBioC, SIMEU, SIMEUP, SIPMeL and Siset. Haemophilia. 2020 Nov;26(6): 937-945.
- Oldenburg J, et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med. 2017 Aug 31;377(9):809-818.
- Young G, et al. A multicenter, open-label phase 3 study of emicizumab prophylaxis in children with hemophilia A with inhibitors. Blood. 2019 Dec 12;134(24):2127-2138.
- Mahlangu J, et al. Emicizumab Prophylaxis in Patients Who Have Hemophilia A without Inhibitors. N Engl J Med. 2018 Aug 30;379(9):811-822.
- Pipe SW, et al. Efficacy, safety, and pharmacokinetics of emicizumab prophylaxis given every 4 weeks in people with haemophilia A (HAVEN 4): a multicentre, open-label, non-randomised phase 3 study. Lancet Haematol. 2019 Jun;6(6):e295-e305.
- Shima M, et al. A multicentre, open-label study of emicizumab given every 2 or 4 weeks in children with severe haemophilia A without inhibitors. Haemophilia. 2019 Nov;25(6):979-987.
- Jiménez-Yuste V, et al. Safety and efficacy of long-term emicizumab prophylaxis in hemophilia A with factor VIII inhibitors: A phase 3b, multicenter, single-arm study (STASEY). Res Pract Thromb Haemost. 2022 Nov 14;6(8):e12837.
- Mahlangu J, et al. Long-term outcomes with emicizumab in hemophilia A without inhibitors: results from the HAVEN 3 and 4 Studies. Res Pract Thromb Haemost. 2024 Mar 1;8(2):102364
- Kiialainen A, et al. Effect of emicizumab prophylaxis on bone and joint health markers in people with haemophilia A without factor VIII inhibitors in the HAVEN 3 study. Haemophilia. 2022 Nov;28(6):1033-1043.
- Kruse-Jarres R, et al. Evolution of joint health and physical activity in people with hemophilia A without factor VIII inhibitors switching to emicizumab prophylaxis: A second interim analysis of the BEYOND ABR study. Blood 146(2025) 1285-1286.
- Shima M, et al. AOZORA study: 3-year interim analysis of safety and joint health in pediatric people with hemophilia A receiving emicizumab prophylaxis. Res Pract Thromb Haemost. 2025 Oct 21;9(8):103228.
- Poenaru DV, et al. Orthopaedic and surgical features in the management of patients with haemophilia. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014 Jul;24(5):685-92.
- Gualtierotti R, et al. Hemophilic arthropathy: Current knowledge and future perspectives. J Thromb Haemost. 2021 Sep;19(9):2112-2121.
- Kenet G, et al. Real-World Rates of Bleeding, Factor VIII Use, and Quality of Life in Individuals with Severe Haemophilia A Receiving Prophylaxis in a Prospective, Noninterventional Study. J Clin Med. 2021 Dec 18;10(24):5959.
- Kempton C, et al. Development and testing of the Satisfaction Questionnaire with Intravenous or Subcutaneous Hemophilia Injection and results

- | |
|---|
| <p>from the Phase 3 HAVEN 3 study of emicizumab prophylaxis in persons with haemophilia A without FVIII inhibitors. Haemophilia. 2021 Mar;27(2):221-228.</p> <p>27. Schmitt C, et al. Emicizumab dose up-titration in case of suboptimal bleeding control in people with haemophilia A. Haemophilia. 2023 Jan;29(1):90-99.</p> <p>28. NHS England Reference: 170134/P(August 2019) Clinical Commissioning Policy: Emicizumab as prophylaxis in people with congenital haemophilia A without factor VIII inhibitors (all ages)</p> <p>29. Aetna: Specialty Pharmacy Clinical Policy Bulletins Aetna Non-Medicare Prescription Drug Plan Subject: Hemlibra SGM 2417-A, 3536-A P2025(May 20, 2025)</p> |
|---|

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[339] Romiplostim 주사제(품명: 로미플레이트주250 마이크로그램)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여하는 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 가. (생 략) 나. (생 략)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여하는 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음)	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 참조하여 이전에 치료경험이 없는 중증 재생불량성 빈혈 환자에서 면역억제요법과 병용 치료에 급여 확대함
	<u><신 설></u>	<u>다. 이전에 치료경험이 없는 성인 중증</u>	

		재생불량성 빈혈 환자에서 면역억제요법과 병용 치료 1) 투여대상: 골수검사 결과 세포충실도가 현저히 낮으면서 (Cellularity가 25% 이하이거나 25~50%라도 조혈관련세포가 남아있는 세포의 30% 이하), 말초혈액검사 결과에서 다음 중 2개 이상의 소견이 확인되는 경우 - 다 음 - - 절대호중구 수(ANC) $500/\mu\text{l}$ 이하 - 교정 망상적혈구 1.0% 이하 또는 절대 망상적혈구 수 $60 \times 10^9/\text{L}$ 이하 - 혈소판 수 $20,000/\mu\text{l}$ 이하 2) 투여개시: 이전에 치료 경험이 없으면서 동종조혈모세포이식(Allogeneic stem cell transplantation)이 불가능하거나 적합한 공여자가 없는 경우 3) 투여방법: 동 약제는 면역억제요법과 병용투여함. - ATG(Anti-human thymocyte immunoglobulin)와 Cyclosporine 병용 4) 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인	
--	--	--	--

		<u>정함.</u> - 다만, 동 약제 투여기간 동안 면역억제요법과 병용 투여에도 불구하고 치료 반응*이 없는 경우, 이후 상기 나. 의 2차 약제로 재투여 시 요양급여로 인정하지 아니함. ※ 치료 반응: BSH 가이드라인에 따른 수혈 비의존 상태를 유지하면서, 더 이상 중증 재생불량성 빈혈의 진단 기준에 해당하지 않는 경우	
	2. (생 략)	2. (현행과 같음)	

※ 관련근거 · 식품의약품안전처 허가사항 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025, Chapter 107: Bone Marrow Failure Syndromes Including Aplastic Anemia and Myelodysplasia · Hematology Basic Principles and Practice, 8e, 2022_Chapter 31 APLASTIC ANEMIA · Williams Hematology, 10e, 2021 > Chapter 36: Aplastic Anemia: Acquired and Inherited · (DRAFT) Korean Expert Recommendations for the Use of Thrombopoietin Receptor Agonists in Severe Aplastic Anemia (2026) · 再生不良性貧血治療の新時代 臨床血液學2025 ―新時代を見据えた治療 戦略 (赤血球系疾患) · (DRAFT) American Society of Hematology 2026 guidelines for diagnosis and management of severe severe acquired aplastic anemia · Babushok DV, et al. Modified Delphi panel consensus recommendations for management of severe aplastic anemia. Blood Adv. 2024 Aug 13;8(15):3946-3960. · Kulasekararaj A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia: A British Society for Haematology Guideline. Br J Haematol. 2024 Mar;204(3):784-804. · The EBMT Handbook: Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapies (2024)			
--	--	--	--

· Lee JW, et al. Addition of romiplostim to immunosuppressive therapy as first-line treatment for patients with aplastic anemia. Blood Adv. 2025 Nov 25;9(22):5732-5735. · Lee JW, et al. Romiplostim with ciclosporin A in patients with aplastic anaemia naïve to immunosuppressive therapy: A phase 2/3 study. Br J Haematol. 2025 Aug;207(2):582-590. · Long-term follow-up of patients with aplastic anemia enrolled in two phase 2/3 trials of immunosuppressive therapy plus romiplostim as a first-line treatment: Final report for up to 5 years			
---	--	--	--

[396] 당뇨병용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[396] Empagliflozin 경구제 (품명: 자디앙정 10밀리그램 등)	1. 제2형 당뇨병에 투여 시 [일반원칙] 당뇨병용제 “세부사항” 범위 내에서 요양급여를 인정함. 2. 허가사항 범위 내에서 상기 1. 이외에 비당뇨 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (중 략) 나. 다음을 모두 만족하는 만성 신장병 환자 - 다 음 - 1) ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제를 최대내약용량으로 4주 이상 안정적으로	1. (좌 동) 2. (좌 동) 나. 다음을 모두 만족하는 만성 신장병 환자 - 다 음 - 1) ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제를 최대내약용량으로 4주 이상 안정적으로	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여, 만성 신장병에 급여 범위를 확대함.

	투여 중인 경우 2) eGFR이 20 – 75ml/min/1.73m² 3) 요 시험지붕 검사(dipstick test)가 양성(1+ 이상)이거나, uACR이 200mg/g 이상인 경우 ※ 동 약제는 다른 신장병 표준치료와 병용하여 투여함.	투여 중인 경우 2) eGFR이 20 – <u>90ml/min/1.73m²</u> 3) 다음 중 한 가지에 해당하는 경우 가) $20 \leq \text{eGFR} < 45\text{ml/min/1.73m}^2$ 나) eGFR이 45 – <u>90ml/min/1.73m²</u> 경우에는 는 uACR 200mg/g 또는 <u>uPCR</u> <u>300mg/g 이상</u>인 경우 ※ 동 약제는 다른 신장병 표준치료와 병용하여 투여함.	
※ 관련근거 1. Goldman-Cecil Medicine. 27th, 831-840.e2(2024) 2. Comprehensive Clinical Nephrology(2024) 3. 만성콩팥병 임상진료지침(대한의학회, 2022) 4. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. 5. UK Kidney Association Clinical Practice Guideline: Sodium Glucose Co transporter 2 (SGLT 2) Inhibition in Adults with Kidney Disease2023 UPDATE. 6. W.G. Herrington et al. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2023;388:117-27. 7. W.G. Herrington et al. Long-Term Effects of Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2025;392:777-87. 8. Richard Haynes. Effects of empagliflozin on progression of chronic kidney disease: a prespecified secondary analysis from the EMPA-KIDNEY trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2024; 12: 39-50. 9. [NICE] Empagliflozin for treating chronic kidney disease(TA942) (2023.12.20.) 10. [SMC] empagliflozin(SMC2642, 2024.7.8.) 11. [PBAC] Public Summary Document – May 2025 PBAC Meeting			